

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif bozukluklar, kişinin kendisiyle, bedeniyle, duygularıyla, anılarıyla veya çevresiyle olan bağlantısında değişiklikler yaşadığı ruhsal bozukluklardır. Kişi kendisini sanki dışarıdan izliyormuş gibi hissedebilir, kendi bedenini veya duygularını kendisine ait değilmiş gibi algılayabilir ya da çevresini gerçek dışı ve uzak hissedebilir. Bazı durumlarda ise özellikle travmatik yaşantılarla ilişkili anılara ulaşmakta güçlük yaşanabilir. Bu nedenle dissosiyasyon, yalnızca “bir şeyi unutmak” olarak değil, kişinin kendisini ve yaşadıklarını bir bütün olarak deneyimleme biçiminin değişmesi olarak düşünülebilir.

Bu durumun anlaşılmasında beynin benlik, duygu, hafıza ve bilişsel kontrol ile ilişkili bölgeleri önem taşımaktadır. Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarında dissosiyatif bozukluğu olan kişilerde beynin bazı bölgelerinde sağlıklı bireylere göre farklı aktivasyonlar görülmüştür. Bu değişiklikler özellikle prefrontal korteks, anterior singulat korteks, amigdala, hipokampus, parahipokampal girus, insula ve talamus gibi bölgelerde dikkat çekmektedir. Ancak bu bulgular, dissosiyatif bozuklukların beynin tek bir bölgesindeki problemden kaynaklandığını göstermemektedir. Aksine, birbiriyle bağlantılı birçok beyin bölgesinin farklı şekilde çalışması söz konusudur.

Özellikle depersonalizasyon yaşayan kişilerde bu durum daha anlaşılır hale gelmektedir. Kişi kendi yüzünü tanıyabilir ve aynadaki kişinin kendisi olduğunu bilmesine rağmen, o yüzü veya kendisini duygusal olarak kendisine ait hissetmeyebilir. Araştırmalarda kendi yüzü ile yabancı yüzler karşılaştırıldığında, sağ anterior singulat korteks ve medial prefrontal korteks gibi bölgelerde artmış aktivasyon görülmüştür. Bu bulgular, kişinin kendisini tanıması ile kendisine aitlik hissi arasında bir uyumsuzluk olabileceğini düşündürmektedir. Yani sorun kişinin “Bu benim” bilgisini kaybetmesi değil, “Bu gerçekten benim” hissinin farklılaşması olabilir.

Duyguların işlenmesinde de farklılıklar görülmektedir. Depersonalizasyonu olan kişilerde duygusal yüz ifadelerine karşı amigdala ve diğer limbik bölgelerde daha düşük aktivasyon bildirilmiştir. Limbik sistem duygusal deneyimlerin işlenmesinde önemli olduğu için bu durum, kişinin duygularını eskisi kadar yoğun veya kendisine ait hissetmemesiyle ilişkili olabilir. Böylece dissosiyasyonun yalnızca benlik algısıyla değil, duyguların deneyimlenmesiyle de bağlantılı olduğu görülmektedir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu’nda (DID) ise beyin aktivitesindeki farklılıklar daha karmaşık bir görünüm ortaya koymaktadır. Araştırmalarda, kişinin travmayla ilişkili kimlik durumu ile görünüşte normal kimlik durumu arasında farklı beyin aktivasyonları bulunmuştur. Travmatik anılar yeniden canlandığında amigdala, insula, parahipokampal girus ve kaudat gibi bölgelerde değişiklikler

gözlenmiştir. Buna karşılık bazı travmayla ilişkili durumlarda prefrontal korteks ve çalışma belleğiyle ilgili bölgelerde aktivasyon azalabilmektedir. Nötr durumlarda ise bazı prefrontal ve parietal bölgelerde daha fazla aktivasyon görülebilmektedir. Bu nedenle dissosiyatif bozukluklarda beynin genel olarak “daha az çalıştığını” söylemek doğru değildir; beynin farklı durumlarda farklı şekilde çalıştığı görülmektedir.

Bu bulguların önemli bir kısmı travma, hafıza ve duygu düzenleme arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Örneğin hipokampus ve parahipokampal bölgeler hafıza süreçleriyle, amigdala duygusal ve tehdit içeren bilgilerin işlenmesiyle, insula ise kişinin kendi bedeninden gelen duyumları ve duygusal durumları fark etmesiyle ilişkilidir. Bu bölgelerdeki farklı aktivasyonlar, travmatik yaşantıların bazı kişilerde neden çok yoğun biçimde yeniden yaşanabildiğini, bazı durumlarda ise uzak, kopuk veya erişilemez hissedilebildiğini anlamaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak dissosiyatif bozuklukları yalnızca “gerçeklikten kopma” veya “hafıza kaybı” olarak değerlendirmek yeterli değildir. Elde edilen nörogörüntüleme bulguları, bu bozukluklarda kişinin kendisi, bedeni, duyguları ve anıları arasındaki bağlantının farklılaşabileceğini göstermektedir. Özellikle

prefrontal ve limbik bölgeler ile hafıza ve beden farkındalığıyla ilişkili alanlarda görülen değişiklikler, dissosiyatif yaşantıların beyindeki karşılıklarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte çalışmaların çoğunda örneklem sayılarının küçük olması ve yöntemlerin birbirinden farklı olması nedeniyle bu bulgular kesin neden-sonuç ilişkileri olarak değerlendirilmemelidir. Yine de genel olarak ortaya çıkan tablo şudur: Dissosiyatif bozukluklarda kişi yalnızca bir şeyi unutmaz veya çevresinden kopmaz; kendisini, duygularını, bedenini ve geçmiş deneyimlerini bir bütün olarak hissetme biçimi değişebilir.

Kaynaklar:

- 1) Purcell JB, Brand B, Browne HA, Chefetz RA, Shanahan M, Bair ZA, Baranowski KA, Davis V, Mangones P, Modell RL, Palermo CA, Robertson EC, Robinson MA, Ward L, Winternitz S, Kaufman ML, Lebois LAM. Treatment of dissociative identity disorder: leveraging neurobiology to optimize success. *Expert Rev Neurother*. 2024 Mar;24(3):273-289. doi: 10.1080/14737175.2024.2316153. Epub 2024 Feb 15. PMID: 38357897; PMCID: PMC10950423.
- 2) Modesti MN, Rapisarda L, Capriotti G, Del Casale A. Functional Neuroimaging in Dissociative Disorders: A Systematic Review. *J Pers Med*. 2022 Aug 29;12(9):1405. doi: 10.3390/jpm12091405. PMID: 36143190; PMCID: PMC9502311

Ali Bocakkıtaç/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University